EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 89452
SERVICIO : AREA QUIRÚRGICA HSC
FECHA : 2024-07-27 13:28:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MATILDE DEL CARMEN PARRA ZAPATA			RUN	: 6.695.008-5
F.Nac	: 09-04-1953	Edad	: 71 AÑOS, 3 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: LA GLORIA			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 232060408		
Fecha Ingreso	: 2024-07-27	Fecha Egreso	: 2024-07-27 13:28:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Pielonefritis aguda
DM2 IR
HTA
ERC
Dilatacion BV en estudio

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec de DM2 IR; HTA; consulta en SU HSC el 26/07 por cuadro de una semana de evolucion de CEG; disuria. Se solicitan examenes de lab al ingreso, donde se evidencia glicemia 460; crea 2,1; LDH 151; PCR 242,3; Na/K/Cl 138/4.8/96; Hb 11.9; Gb 17,6; INR 1,18; orina con presencia de cetonas, de aspecto turbio, 500 leu/ul. Osm calculada 306. Se decide ingreso para terapia ATB en vias de no disponibilidad de cupos en HODOm.
Se solicita uroTAC, que reporta signos de PNAg bilateral, lev fidroureteronefrosis bilateral, engrosamiento y realce aprietal de ambos ureteres, que podria etar en contexto de proceso inflamatorio infeccioso, signos de cistitis, dilatacion de VB intra y extra hepatica sin factor obstructivo evidente.
Paciente actualmente cursanso su dia N° 1 hospitalizada, dia N° 1 de ceftriaxona, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso/urinario: Paciente actualmente cursando con infeccion de via urinaria, uroTAC reporta signos de pielonefritis aguda bilateral, leve hidroureteronefrosis bilateral, se continuara con terapia ATB via HODOm, control con parametros inflamatorios en 24 hrs
4) Cirurigico: EN vista de hallzgos en TAC; se complementara estudio con eco abdominal y seguimiento ambulatorio por parte de cirugia

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada 30°
2. Regimen diabetico hiposodico a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 6 dias
4. Metoclopramida 10 mg c/8 hrs VO por 6 dias
5. Omeprazol 20 mg al dia VO por 6 dias
6. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8 hrs VO SOS por 6 dias
7. Insulina NPH 28 UI AM SC
8. Hidroclorotiazida 25 mg AM VO
9. Losartan 50 mg 1 cada 12 hrs VO
10. Atorvastatina 20 mg por dia VO
11. Amlodipino 10 mg 1 al dia PM VO

12. Examenes de control 28/07
13. Pendiente toma de eco abdominal (ambulatoria)
14. Pendiente rescate de cultivos
15. CSV c/8 hrs

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO